



DII: Diagnóstico Endoscópico, Radiológico e Histológico

Apostila 3 — Páginas 41 a 60 | Doença Inflamatória Intestinal

GASTROENTEROLOGIA

DIAGNÓSTICO AVANÇADO

O Diagnóstico da DII é Multidimensional

O diagnóstico da Doença Inflamatória Intestinal não depende de um único exame isolado. Ele é construído a partir da **integração entre dados clínicos, laboratoriais, endoscópicos, histológicos e de imagem**. Essa abordagem multidimensional é fundamental porque muitas doenças podem simular a DII — e o erro diagnóstico pode levar a tratamentos inadequados e até prejudiciais ao paciente.

Dados Clínicos

Histórico, sintomas e evolução do paciente

Laboratoriais

Marcadores inflamatórios e sorológicos

Endoscopia

Visualização direta da mucosa intestinal

Imagem

TC, RM, ultrassonografia e enterografia

Histologia

Análise microscópica das biópsias



Indicações de Colonoscopia na DII

A colonoscopia é um dos principais exames na investigação da DII, sendo indicada em múltiplos contextos clínicos — desde a confirmação diagnóstica inicial até o seguimento evolutivo do paciente ao longo do tratamento.

Indicações Principais

- Confirmação diagnóstica inicial
- Diferenciação entre Crohn e RCU
- Avaliação da extensão da doença
- Monitoramento da atividade inflamatória
- Seguimento evolutivo do paciente
- Avaliação de reservatórios pós-cirúrgicos

⚠ Contraindicações

- Suspeita de **perfuração intestinal**
- **Megacólon tóxico**
- Doença muito grave com alto risco de complicação

📌 Nesses casos, métodos menos invasivos devem ser priorizados inicialmente.

Achados Endoscópicos da Retocolite Ulcerativa

Na Retocolite Ulcerativa, a inflamação apresenta um **padrão contínuo** — não há áreas de mucosa normal entre as regiões acometidas. A transição entre mucosa normal e doente costuma ser bem definida. Reconhecer esses padrões é essencial para a diferenciação diagnóstica.



Edema e Hiperemia

Mucosa avermelhada, edemaciada, com perda do padrão vascular normal



Friabilidade

Sangramento ao toque durante o exame, sinal de inflamação ativa



Muco e Exsudato

Secreções visíveis na superfície da mucosa comprometida



Úlceras Superficiais

Lesões rasas que não ultrapassam a camada mucosa

Escore de Mayo Endoscópico

O Escore de Mayo é o principal instrumento para **classificar a gravidade da Retocolite Ulcerativa** com base nos achados endoscópicos. É amplamente utilizado tanto na prática clínica quanto em estudos e ensaios clínicos para mensurar resposta ao tratamento.

1

Grau 0

Mucosa normal, sem sinais de inflamação

2

Grau 1

Inflamação leve: edema discreto e pequenos pontos hemorrágicos

3

Grau 2

Inflamação moderada com erosões visíveis e friabilidade aumentada

4

Grau 3

Doença grave com ulcerações extensas e sangramento espontâneo

Achados Endoscópicos da Doença de Crohn

Diferente da Retocolite, a Doença de Crohn apresenta um **padrão descontínuo** — áreas de mucosa normal intercaladas com áreas inflamadas. Esse padrão é uma das principais pistas diagnósticas na endoscopia.

Úlceras Aftosas

Lesões iniciais pequenas, semelhantes a aftas, sobre mucosa normal

Úlceras Lineares Profundas

Lesões alongadas que penetram além da mucosa superficial

Aspecto "Cobblestone"

Padrão em "pedra de calçamento" formado pela combinação de úlceras e edema

Descontinuidade

Áreas de mucosa absolutamente normal entre regiões inflamadas



Distribuição e Comprometimento na Doença de Crohn

Segmentos Preferencialmente Acometidos

A Crohn pode afetar qualquer segmento do trato gastrointestinal, da boca ao ânus. No entanto, apresenta predileção por áreas específicas:

- **Íleo terminal** — área mais frequentemente afetada
- **Região ileocólica** — padrão muito comum
- **Cólon** — acometimento isolado possível

📌 O reto frequentemente está **poupado** na Crohn — importante diferencial com a RCU, onde o reto é quase sempre comprometido.

⚠️ Comprometimento Perianal

Uma característica marcante e praticamente exclusiva da Crohn é o **acometimento perianal**, incluindo:

- Fístulas perianais
- Abscessos
- Fissuras atípicas

Esse padrão é raro na Retocolite Ulcerativa e tem alto valor diagnóstico diferencial.

Outros Exames Endoscópicos na DII

Além da colonoscopia convencional, outros procedimentos endoscópicos complementam a investigação da DII, especialmente quando há suspeita de comprometimento do intestino delgado ou de segmentos superiores do trato digestivo.



Endoscopia Digestiva Alta

Indicada quando há sintomas do trato digestivo superior. Avalia esôfago, estômago e duodeno em busca de lesões sugestivas de Crohn



Cápsula Endoscópica

Excelente para avaliação do intestino delgado. **Contraindicada em estenoses** — risco de retenção da cápsula no segmento estreitado



Enteroscopia

Utilizada em casos selecionados quando há necessidade de biopsia ou tratamento em segmentos do delgado inacessíveis pela colonoscopia



CAPÍTULO 2

Diagnóstico por Imagem na DII

Os exames de imagem são fundamentais especialmente na Doença de Crohn, onde há comprometimento **transmural** e complicações estruturais como fístulas, estenoses e abscessos que não são visíveis apenas pela endoscopia.

Enterografia por TC e Ressonância Magnética

Esses exames permitem avaliar o intestino delgado com maior precisão, identificando tanto a atividade inflamatória quanto as complicações estruturais da Doença de Crohn. São os métodos de imagem mais utilizados na prática clínica atual.



Espessamento da Parede

Indicativo de inflamação ativa transmural no segmento intestinal comprometido



Realce da Mucosa

Captação aumentada do contraste reflete hiperemia e atividade inflamatória



Inflamação da Gordura

Processo inflamatório se estende ao tecido adiposo perintestinal — sinal de transmural



Fístulas e Estenoses

Complicações estruturais detectadas com alta precisão nesses exames

TC vs. Ressonância Magnética: Qual Escolher?

A escolha entre Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética deve ser guiada pelo **contexto clínico**, pela disponibilidade do serviço e pelas características individuais de cada paciente.

Tomografia Computadorizada (TC)

- **Mais disponível** na maioria dos serviços
- Exame mais **rápido** — vantagem em urgências
- Boa detecção de complicações agudas
- ⚠ Usa **radiação ionizante** — relevante em pacientes jovens com doença crônica

Ressonância Magnética (RM)

- **Sem radiação** — preferível no seguimento crônico
- Melhor avaliação **funcional** e de tecidos moles
- Mais detalhada para fístulas e abscessos pélvicos
- ⚠ Menor disponibilidade e maior tempo de exame

Ultrassonografia Intestinal

Método de imagem **cada vez mais valorizado** na DII por combinar praticidade, segurança e boa capacidade diagnóstica. Permite avaliação em tempo real, sem exposição à radiação e com custo reduzido — sendo especialmente útil no seguimento ambulatorial.

Vantagens

- Não invasivo
- Sem radiação ionizante
- Baixo custo relativo
- Repetível com segurança

O que Avalia

- Espessura da parede intestinal
- Estratificação das camadas
- Vascularização (Doppler)
- Complicações locais

📌 Achados de alerta: espessamento da parede, perda da estratificação normal e aumento da vascularização — todos indicativos de **atividade inflamatória**.

Ressonância Magnética de Pelve

A RM de pelve é o **exame de escolha** para avaliação das complicações perianais da Doença de Crohn. Sua superioridade em relação a outros métodos se deve à alta resolução de contraste para tecidos moles, permitindo mapear com precisão a extensão e anatomia das lesões.



Fístulas Perianais

Identifica trajeto, complexidade e relação com os esfíncteres — essencial para o planejamento cirúrgico



Abscessos Perianais

Localiza coleções purulentas, define extensão e orienta a drenagem cirúrgica adequada



Fundamental na Crohn perianal — guia tanto o tratamento clínico quanto a intervenção cirúrgica.



CAPÍTULO 3

Histopatologia na DII

A análise microscópica das biópsias é **essencial para a confirmação diagnóstica** da DII, especialmente nos casos duvidosos onde a endoscopia e os exames de imagem não são conclusivos. A histopatologia oferece informações que nenhum outro método consegue fornecer.



Achados Histológicos na Retocolite Ulcerativa

O padrão microscópico da Retocolite Ulcerativa reflete a natureza **superficial e contínua** da inflamação. As alterações são predominantemente restritas à camada mucosa, sem envolvimento das camadas mais profundas da parede intestinal.

Inflamação Limitada à Mucosa

A submucosa e as camadas mais profundas são preservadas — característica fundamental da RCU

Infiltrado Inflamatório Crônico

Presença de plasmócitos e linfócitos na lâmina própria da mucosa

Abscessos de Criptas

Acúmulo de neutrófilos no interior das criptas glandulares — sinal de atividade inflamatória

Distorção Glandular

Alteração da arquitetura das glândulas intestinais — evidência de doença crônica estabelecida

Achados Histológicos na Doença de Crohn

O padrão microscópico da Doença de Crohn reflete sua natureza **transmural e focal**. As alterações afetam todas as camadas da parede intestinal e têm distribuição irregular, diferente do padrão contínuo da RCU.

Inflamação Transmural

Comprometimento de todas as camadas da parede — mucosa, submucosa, muscular e serosa

Granulomas Não Caseosos

Achado patognomônico da Crohn quando presente — formações de células epitelioides sem necrose central

Distribuição Irregular das Lesões

Padrão focal e segmentar, com áreas normais entre regiões inflamadas — reflete a descontinuidade macroscópica

📌 ⚠️ **Atenção:** Nem todos os casos de Crohn apresentam granulomas. A ausência deles não exclui o diagnóstico.

Diferenciação Histológica: Crohn vs. Retocolite

A comparação histológica entre as duas doenças é um dos pilares do diagnóstico diferencial da DII. Conhecer esses padrões permite ao clínico interpretar laudos com segurança e conduzir o raciocínio diagnóstico com precisão.

Característica	Retocolite Ulcerativa	Doença de Crohn
Distribuição	Contínua	Segmentar / focal
Profundidade	Restrita à mucosa	Transmural
Granulomas	Ausentes	Presentes (quando há)
Abscessos de criptas	Frequentes	Menos frequentes
Distorção glandular	Marcada	Variável
Comprometimento perianal	Raro	Comum

Visão Integrada: Crohn vs. Retocolite

Integrar os achados endoscópicos, de imagem e histológicos é o que permite o diagnóstico definitivo da DII e a diferenciação precisa entre as duas principais formas da doença.

DOENÇA DE CROHN

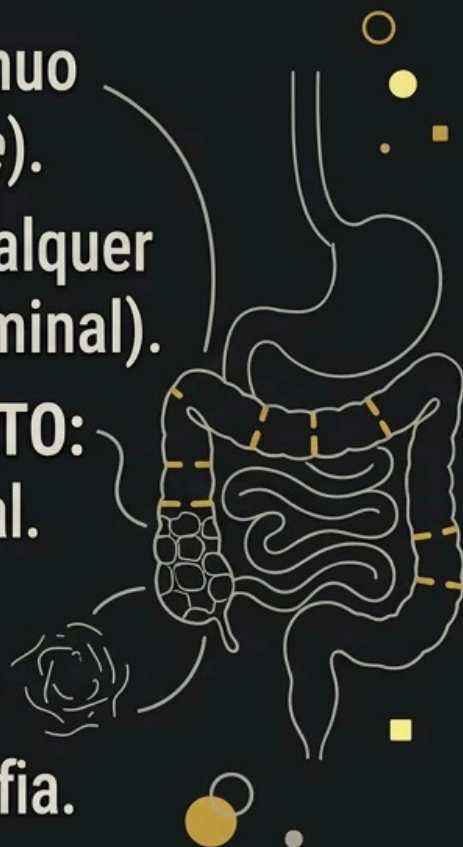
PADRÃO: Descontínuo (aftas, *cobblestone*).

DISTRIBUIÇÃO: Qualquer segmento (íleo terminal).

COMPROMETIMENTO: Transmural, perianal.

HISTOLOGIA: Granulomas.

IMAGEM: Enterografia.



RETocolite ULCERATIVA (RCU)

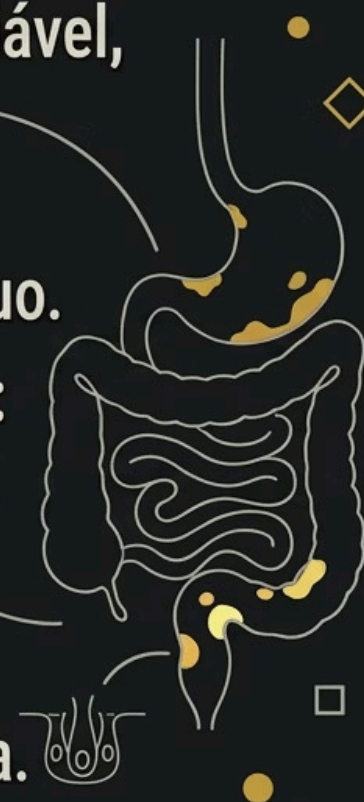
PADRÃO: Contínuo (friável, superficiais).

DISTRIBUIÇÃO: Reto comprometido, contínuo.

COMPROMETIMENTO: Mucosa, sem perianal.

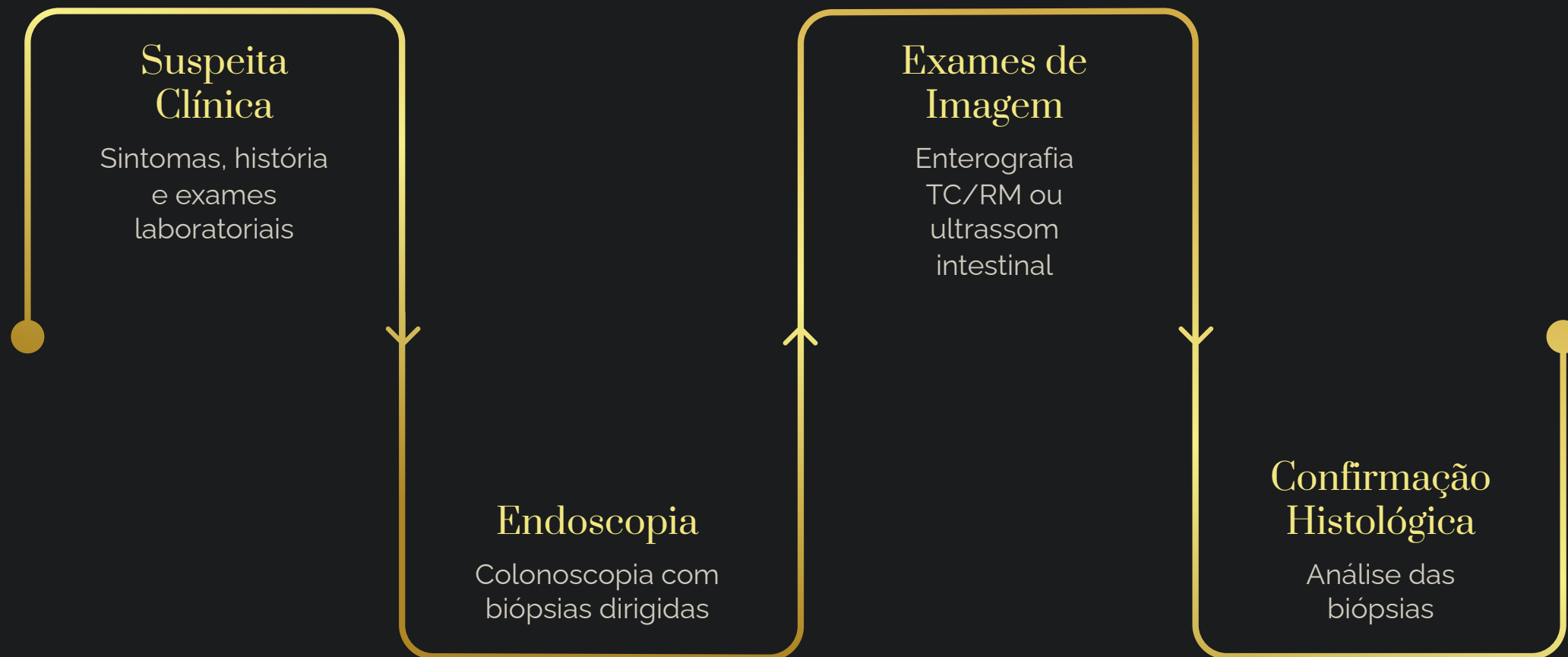
HISTOLOGIA: Abscessos criptas.

IMAGEM: Colonoscopia.



Fluxo Diagnóstico da DII

Na prática clínica, o diagnóstico da DII segue uma sequência lógica que parte da suspeita clínica e avança de forma sistematizada até a confirmação histológica. Conhecer esse fluxo é essencial para uma abordagem eficiente e segura.



A integração dos dados de cada etapa é o que garante o diagnóstico correto. Em casos duvidosos, múltiplos exames devem ser correlacionados antes de definir a conduta terapêutica.

Pontos-Chave: O que Todo Clínico Precisa Saber

Uma síntese dos conceitos fundamentais abordados nesta apostila — base para uma abordagem diagnóstica segura e eficaz na DII.

1 Diagnóstico Multidimensional

Nunca basear o diagnóstico em um único exame. Integrar clínica, endoscopia, imagem e histologia.

2 Padrão Contínuo vs. Descontínuo

RCU = inflamação contínua, restrita à mucosa. Crohn = padrão focal, transmural, com reto frequentemente poupado.

3 Imagem é Essencial na Crohn

Enterografia por TC ou RM e RM de pelve são fundamentais para avaliar complicações transmurais e perianais.

4 Histologia Confirma o Diagnóstico

Granulomas apontam para Crohn; abscessos de criptas e distorção glandular são marcas da RCU.

